جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : فوزيه الشايب عبدالدايم علي
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** امبابه **العنوان :** ~~ امبابه - الجيزه
رقم البطاقة : 26011172101526 **رقم التليفون :** 01125518787 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 17-11-1960 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: فوزيه الشايب عبدالدايم علي
National ID: 26011172101526

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

الاربعاء

١٢/١٠



٣٦٧٥



National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

جوستاف روسي انترناشونال

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

الست المصرية هي صحة مصر

MDT FORM 15/1 /2026 G

Name	فوزية الحايب عبد الرايم	MRN	٣٦٧٥
		ID	C-CO
Age	65 Y	Phone	٠١١١٦٤٨٠١٥٢
Menopausal status	post-menopausal	Marital status	C٦٠١١١٧٤١٠١٥
NRS SCORE		Family history	
BMI		REASON OF MDT	New 2 BA (Severe)
CO morbidity	D.M HTN IHD CKD		

Clinical Data

BX: Intermediate grade duct Carcinoma in situ (R) (L)

ER: 0/8	PR:	HER 2: NGRC	Ki67:



Sonomammography: UIQ focal Asymmetry with clusted pleomorphic microcalcifications 4.5 X 4 cm

Mets Workup: TNM

Recommendations: * for possibility of upfront Lt Cardio SLNB + Nephro Consult chest, CT/MRI/PT is high risk. CESM Couldn't Be Done Due to ↑ KFTs

MDT OUTCOME & PLAN

For Lt BCS ± SLNB.

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

Patient Name	: الأستاذه / فوزيه الشايب عبدالدايم	Request No.	: 13002230
Patient No.	: 26011172101526	Request Date	: 08/11/2025
Path No.	: 3433/25	Verification Date	: 18/11/2025
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 64 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data
Left breast mass.

Nature of specimen
Tru cut biopsy collected on 8/11/2025.

Gross examination
Three grey white tissue cores ranging in size from 0.5 cm up to 1 cm , totally submitted .
Technique:
- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against: HER2/NEU (4B5),KI67 (30-9), PR (1E2), ER (SP1).

Microscopic examination
* Histological type: Duct carcinoma insitu , cribriform pattern with comedo type necrosis .
* Grade :Intermediate grade
• IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
* ER: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)

Diagnosis
LEFT BREAST MASS,TRU CUT BIOPSY
-Intermediate grade duct carcinoma insitu , cribriform pattern with comedo type necrosis , No invasive lesion in submitted material .
IPT:
* ER: Negative (score 0/8).
* Scoring system: "ER, PR"

Verified by :
Dr.Heba Hasan

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

Patient Name	: الأستاذه / فوزيه الشايب عبدالدايم	Request No.	: 13002230
Patient No.	: 26011172101526	Request Date	: 08/11/2025
Path No.	: 3433/25	Verification Date	: 18/11/2025
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 64 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

Signature
Dr.Walaa Ibrahim Ghoneim
Dr.Heba El-Shafeey

Verified by :
Dr.Heba Hasan

CAP ACCREDITED

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name: Fawzeya Al Shayeb Abd Al Dem	Date : 30/10/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 65 Year(s)
Medical ID: 8184	Pat. ID: 132686

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: 65-year-old female with negative family history complaining of left breast lump of a month duration.

Findings:

Right breast.

- Heterogeneously dense breast parenchyma that may obscure small lesions. (ACR c)
- Benign vascular macro-calcifications.
- No speculations, masses asymmetry , distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated heterogeneous breast parenchyma with mottled appearance yet no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast.

- Heterogeneously dense breast parenchyma that may obscure small lesions. (ACR c)
- Benign vascular macro-calcifications.
- UIQ ,focal asymmetry with segmental clustered pleomorphic microcalcifications over an area measuring x 4.5 x 4 cm seen 1 cm from nipple with surrounding distortion.
- **Ultrasound** demonstrated 11-12 o'clock segmental prominent pathological with soft tissue content and calcifications within as well as abnormal vascularity on color Doppler study traced till 1 cm from nipple.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion:-

Right breast (BIRADS 2): benign vascular macro-calcifications.

Left breast (BIRADS 5): UIQ asymmetry with suspicious microcalcifications and distortion.

Recommendation:-

For biopsy and histopathological correlation.

Best Regards,
DR. Amal Hegazi, M.Sc.

BIRADS classification of breast lesions according to the American College of Radiology used for breast assessment combined with recommendations:

Category & recommendations	Suspected Cancer Risk
BIRADS 0: Non-informative study.	
BIRADS 1: Normal study, routing screening	0 %
BIRADS 2: Benign findings, routine screening	0 %
BIRADS 3: Probably benign, for close follow up.	2 %
BIRADS 4: Probably malignant, for biopsy.	50 %
A: mild suspicion.	

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]